Cabinet de dermatologie Es-Senia

تقرير المساعدة على الفرز — آفة جلدية

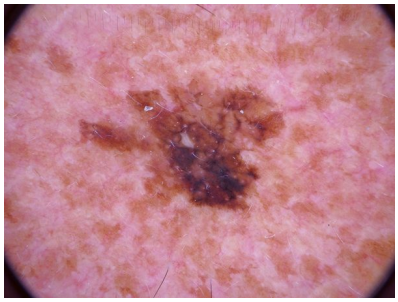
dermIA الإصدار 2.0.0 · النموذج ham10000-m5-v2 الإصدار 2.0.0 (الملف: كامل)

المريض	P-2026-0421	تاريخ التحليل	23:02 01/04/2026
العمر (بالسنوات)	60	طلب التحليل	Dr Karim Haddad
الجنس	ذكر	الموضع	الصدر
الآفة المتابعة	رقم 1 — thorax, région sternale	عتبات القرار	الأصلية

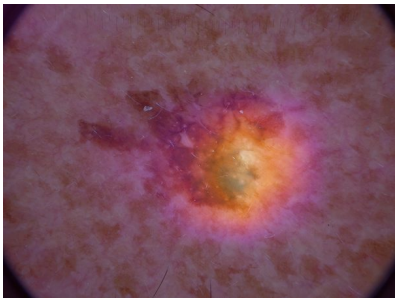
عاجل

اشتباه في ورم ميلانيني

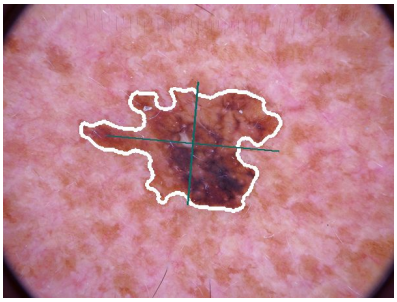
يتجاوز احتمال الورم الميلانيني عتبة الأمان. يوصى بعرض الحالة بسرعة على طبيب الأمراض الجلدية.



الصورة المحللة



المناطق الأكثر تأثيرا (Grad-CAM، «ورم ميلانيني»)



الحدود والمحاور المستخدمة في معايير ABCD

الاحتمالات المقدرة

التشخيص	الاحتمال	ضمن المجموعة المضمونة*
تقرن حميد	57,5%	نعم
ورم ميلانيني	38,4%	نعم
وحمة ميلانينية	3,6%	
ورم ليفي جلدي	0,2%	
تقرن سفعي / داء بوين	0,2%	
سرطانة الخلايا القاعدية	0,1%	
آفة وعائية	0,0%	

* المجموعة المطابقة (طريقة موندريان، ألفا = 0,10): تحتوي على التشخيص الصحيح باحتمال لا يقل عن 90% لكل فئة، بافتراض أن الحالات تشبه بيانات المعايرة. يتخذ قرار الورم الميلانيني إذا كان p(mel) ≥ 0,10 (نسبة التكلفة R = 10).
عتبات النموذج الأصلية، معايرة على مجموعة المعايرة من HAM10000.

معايير ABCD الآلية (استرشادية)

المعيار	القياس	التفاصيل
A — عدم التناظر	2/2	محاور رئيسية غير متناظرة (الشكل أو الألوان)
B — الحواف	8/8	قطاعات ذات حافة حادة
C — الألوان	4/6	بني فاتح، بني داكن، أزرق رمادي، أسود
D — القطر	7,8 مم	أكثر من 6 مم

قياسات آلية استرشادية: على مجموعة الاختبار من HAM10000 لا يميز كل منها بين الورم الميلانيني والوحمة إلا بشكل محدود (AUC من 0,66 إلى 0,73). وهي لا تغني عن الفحص بالمنظار الجلدي.

المراجعة الطبية

أكدها Dr Karim Haddad بتاريخ 02/04/2026.
التشخيص المعتمد: ورم ميلانيني

توقيع الطبيب: _____

تنبيه. أعدت هذه الوثيقة بواسطة أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، وهي لا تعد تشخيصا ولا تغني عن الفحص السريري ولا عن الفحص النسيجي. حالة النموذج: عرض توضيحي — استخدام غير تجاري — ليس جهازا طبيا. بيانات التدريب: HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) — الترخيص CC BY-NC 4.0 (غير تجاري).